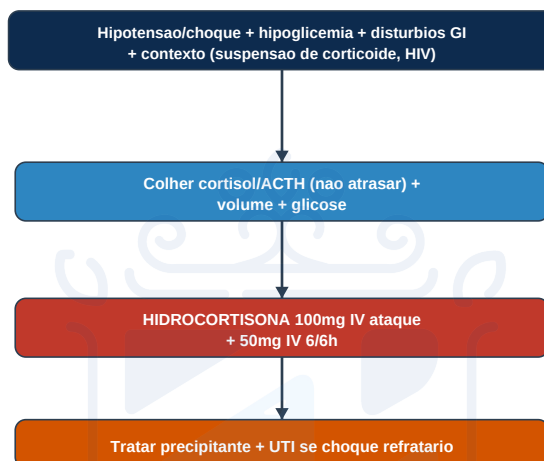


INSUFICIÊNCIA ADRENAL — RECONHECER A CRISE

FLUXOGRAMA — CRISE ADRENAL

CRISE ADRENAL — NÃO ESPERAR CONFIRMAÇÃO



DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

O QUE É

- Redução da produção hormonal adrenal (cortisol +/- aldosterona +/- androgênios)
- PRIMÁRIA (40%): lesão da própria glândula — Addison (autoimune, 70-90%), infecções (TB, paracoccidíose, em HIV/SIDA), fármacos (etomidato, cetoconazol)
- SECUNDÁRIA (60%): doença hipotálamo-hipofisária OU retirada abrupta de corticoide exógeno
- Corticoide crônico (> 3 semanas, >= 40mg prednisona/dia) suprime o eixo — suspensão abrupta = crise

QUANDO SUSPEITAR — POR DÉFICIT HORMONAL

PISTAS CLÍNICAS

- Déficit de GLICOCORTICOIDE: fadiga, astenia, mal-estar, náuseas/vômitos/diarreia, hipotensão, HIPOGLICEMIA
- Déficit de ALDOSTERONA (só na primária): hipovolemia, hiponatremia, HIPERCALEMIA, acidose metabólica leve
- Déficit de ANDROGÊNIO: queda da libido, perda de pilificação (axila/púbis)
- HIPERPIGMENTAÇÃO cutânea/oral (ACTH alto): SÓ na insuficiência adrenal PRIMÁRIA
- Buscar ativamente: suspensão de corticoide, HIV com oportunistas, desmame difícil de amins

INVESTIGAÇÃO — CORTISOL BASAL 8H

Cortisol 8h	Interpretação	Conduta
< 3-5 ug/dL	Confirma insuficiência adrenal	Dosar ACTH (>100 = primária); encaminhar endocrino
5 - 18 ug/dL	Inapropriadamente baixo (zona indeterminada)	Teste da cortrosina (ACTH sintético) ou TTI com especialista
> 18 ug/dL	Exclui insuficiência adrenal	Investigar outras causas

RED FLAGS — CRISE ADRENAL

EMERGÊNCIA: TRATAR ANTES DE CONFIRMAR

- Hipotensão refratária (PAS < 90) ou choque sem outra causa
- Rebaixamento do nível de consciência
- Hipoglicemia sintomática ou refratária a correção IV
- Hiponatremia < 125 / hipercalemia > 6,0 inexplicadas
- Vômitos incoercíveis e desidratação grave — não atrasar a hidrocortisona aguardando exames

MANEJO DA CRISE ADRENAL NO PS

Rx PASSO A PASSO

1. Monitorização multiparamétrica + ECG (avaliar hipercalemia)
2. Acesso calibroso + expansão volêmica para corrigir hipovolemia
3. HGT 1/1h; hipoglicemia: 3-4 ampolas de glicose 50%; se persistente, glicose 10% em BIC 100-150 mL/h
4. HIDROCORTISONA 100mg IV ataque + 50mg IV 6/6h (manutenção)
5. Corrigir distúrbios hidroeletrólíticos + rastrear/tratar precipitante (cultura, RX, TC se HIV)
6. Noradrenalina se PAM < 65 sintomática apesar de volume; vaga de UTI se refratário

CONCEITO — DOSE DE ESTRESSE

POR QUE A HIDROCORTISONA SALVA

- Na crise, o corpo não consegue aumentar o cortisol frente ao estresse (infecção, cirurgia, trauma)
- Hidrocortisona em dose de estresse repõe gluco e, em doses altas, tem efeito mineralocorticoide
- Paciente com IA conhecida em estresse precisa AUMENTAR a dose habitual de corticoide
- Na dúvida diagnóstica com paciente instável: colher cortisol e JÁ tratar (dexametasona não interfere no teste se necessário)

CRITÉRIOS DE ALTA

ALTA SE

- ☐ Estabilidade hemodinâmica sustentada
- ☐ Eletrólitos normalizados e aceitação de via oral
- ☐ Ajuste para corticoide oral estabelecido (retomar prednisona +/- fludrocortisona)
- ☐ Orientação clara sobre DOSE DE ESTRESSE em intercorrências
- ☐ Retorno ambulatorial garantido em 24-48h

PRESCRIÇÃO PARA CASA

Rx AJUSTE AMBULATORIAL (IA CONFIRMADA)

Se cessou a medicação: retomar prednisona e fludrocortisona na dose habitual
Sintomático em terapia: aumentar prednisona (ex.: 3-5mg VO, manhã ou manhã+tarde)
IA primária: fludrocortisona 0,05-0,2 mg às 8h VO (mineralocorticoide)
Parâmetros para titular: PA, sódio/potássio e sintomas gastrointestinais
Reforçar nunca suspender abruptamente e portar identificação de IA

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com crise adrenal (hipotensão/choque + hipoglicemia + distúrbio hidroeletrólítico).
- Contexto: suspensão de corticoide / HIV / IA prévia em estresse. Precipitante: ____.
- Conduta: volume + glicose + hidrocortisona 100mg IV + manutenção; aminos: sim/não.
- Solicito vaga de UTI (se choque refratário) e avaliação de endocrinologia.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente em uso crônico de prednisona 40 mg/dia que suspendeu abruptamente, agora com hipotensão, náuseas e hipoglicemia. Qual a conduta IMEDIATA?

- A) Aguardar o resultado do cortisol antes de qualquer medida
- B) Volume + glicose e hidrocortisona 100 mg IV, sem aguardar confirmação laboratorial
- C) Apenas hidratação venosa
- D) Insulina endovenosa
- E) Suspende qualquer corticoide definitivamente

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual conjunto de alterações é típico da insuficiência adrenal PRIMÁRIA (e não da secundária)?

- A) Hipernatremia e hipocalemia
- B) Hiponatremia, hipercalemia e hiperpigmentação cutânea
- C) Hipocalemia e alcalose
- D) Hiperglicemia e hipertensão
- E) Ausência de qualquer distúrbio eletrolítico

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Na investigação da insuficiência adrenal, qual valor de cortisol basal das 8h CONFIRMA o diagnóstico?

- A) > 18 ug/dL
- B) Entre 5 e 18 ug/dL
- C) < 3-5 ug/dL (inapropriadamente baixo)
- D) Qualquer valor com ACTH baixo
- E) Cortisol das 20h elevado

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual o glicocorticoide e esquema de escolha na crise adrenal?

- A) Prednisona 5 mg VO ao dia
- B) Dexametasona 0,75 mg VO
- C) Hidrocortisona 100 mg IV em ataque, seguida de 50 mg IV 6/6h
- D) Fludrocortisona 0,1 mg VO isolada
- E) Metilprednisolona 4 mg IV dose única

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Paciente com insuficiência adrenal conhecida vai ser submetido a cirurgia/infecção. Qual orientação é correta?

- A) Manter a mesma dose habitual de corticoide
- B) Suspende o corticoide no dia do estresse
- C) Aumentar a dose de corticoide (dose de estresse)
- D) Substituir por anti-inflamatório não esteroide
- E) Reduzir a dose pela metade

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Crise adrenal é diagnóstico clínico-presuntivo: trata-se ANTES de confirmar. Colhe-se cortisol/ACTH, mas a prioridade é volume, glicose e hidrocortisona 100mg IV. Atrasar o corticoide aguardando exame pode ser fatal.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A IA primária acomete também a zona glomerulosa (aldosterona): cursa com hiponatremia, hipercalemia e acidose. O ACTH elevado causa hiperpigmentação. Na secundária a aldosterona é preservada e não há hiperpigmentação.

QUESTÃO 3 → Resposta: C

Cortisol basal às 8h < 3-5 ug/dL é inapropriadamente baixo e confirma IA. Entre 5-18 é zona indeterminada (testar com cortrosina/TTI). > 18 exclui o diagnóstico.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Na crise adrenal, hidrocortisona 100mg IV em ataque seguida de 50mg 6/6h é o esquema de escolha (em dose alta tem efeito mineralocorticoide). Prednisona/dexametasona orais não servem para o paciente instável.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Paciente com IA não eleva o cortisol endógeno frente ao estresse; por isso, em infecção, cirurgia ou trauma deve-se AUMENTAR a dose de corticoide (dose de estresse) para evitar a crise adrenal.

SM24
Suporte ao Plantão Médico